

输尿管重建

WARWIKI

患者须知 · 修复堵塞或狭窄输尿管的手术

输尿管重建是修复堵塞或狭窄输尿管（即将尿液从肾脏输送至膀胱的管道）的手术，目的是恢复尿液通畅引流、保护肾功能。手术方式取决于狭窄的位置和长度，可采用直接吻合修复、组织移植或使用肠管段。

关于这项手术

输尿管**狭窄**（瘢痕性缩窄）会使尿液积聚在狭窄处上方，损伤肾脏。手术方式根据狭窄情况选择：

- **短段狭窄** — 切除病变段后将健康两端缝合，或将输尿管重新接入膀胱（有时需将膀胱向上提拉以便吻合）。
- **较长狭窄** — 用**移植**物补片修复，通常取自口腔内侧颊黏膜（此术式有专属宣教材料）。
- **缺损过长或损伤严重** — 取一段自身**肠管**桥接或替代受损输尿管。

术中放置柔软的内置**支架管（双J管）**，以维持修复处通畅直至愈合。手术通常采用**机器人或腹腔镜**（微创）方式，偶尔需开放手术。成功率高。

安全吗？

这些均为成熟有效的手术方式，方案根据患者个体解剖情况制定。与所有大手术一样，存在一定风险，包括出血、感染或短暂尿液渗漏（通常由支架管和引流管处理）。狭窄复发不常见。若使用肠管段，肠道需要数天恢复，尿液中可能出现少量黏液，属正常现象。

名词解释

输尿管

将尿液从肾脏输送至膀胱的管道。

狭窄

瘢痕形成的缩窄，导致尿液流动减慢或受阻。

输尿管支架管

内置的柔软管道（即“双J管”），在修复处愈合期间维持其通畅。

移植

取自自身的小片组织（常为口腔颊黏膜），用于扩宽输尿管。

肠管段

取自自身肠道的一小段，用于桥接较长缺损。

输尿管再植

将输尿管重新接入膀胱。

肾积水

因尿液在梗阻处积聚而导致的肾脏肿大。

机器人／腹腔镜手术

通过几个小切口进行的微创手术。

会疼吗？ 手术在全身麻醉下进行，术中无感觉。术后切口处会有酸痛感，内置支架管可能引起尿急或轻度侧腹部不适。若使用肠管段，肠道需数天“苏醒”。大多数患者住院1至3天；手术时长因修复方式而异。

如何准备（术前）

- 手术在**全身麻醉**下进行——请遵守所有术前指示（禁食、需暂停的药物，包括抗凝药）。
- 术前需进行**尿液检查**以排查感染——若有感染须先治疗。
- **请勿吸烟**——吸烟会延缓愈合。若可能需使用肠管段，需进行肠道准备；若可能需取颊黏膜，请注意口腔卫生。
- 计划**保留支架管约4至6周**，并安排人接送。

请提前告知您的医疗团队，若您：

- 正在服用**抗凝药**，或当前存在感染
- 曾接受腹部或盆腔手术，或有放疗史

手术过程

- 1 您在麻醉下进入睡眠状态，同时给予抗生素。
- 2 医生做微创或开放切口，暴露狭窄段。
- 3 在支架管支撑下修复输尿管——端端吻合、颊黏膜移植补片修复，或使用肠管段桥接。
- 4 留置小引流管，关闭切口。

之后

- 通常住院**1至3天**后出院。
- **支架管在体内保留约4至6周**，随后在门诊通过快速膀胱镜检查取出。
- 支架管相关症状——尿急、轻度侧腹部不适或尿液略带粉色——均属**正常**。
- 若使用了肠管段，肠道恢复期间宜清淡饮食。数周内请**避免重体力劳动**。

出现以下情况请联系您的医疗团队：

- 发热或寒战
- 严重或加重的侧腹部或腹部疼痛
- 大量出血，或无法排尿
- 持续呕吐，或无排气、无排便（若使用了肠管段）
- 切口处红肿加重、疼痛或有分泌物

需要记住的三件事

1. 输尿管重建可疏通堵塞的输尿管，保护肾脏。手术方案因人而异——端端吻合、颊黏膜移植或肠管段桥接，均在内置支架管支撑下完成。
2. 术前准备：遵守禁食和用药指示，先治疗感染，禁烟，计划保留支架管约4至6周，并安排接送。
3. 支架管取出前可能引起尿急，属正常现象。如出现发热、剧烈疼痛、大量出血、无法排尿或术后无排便，请立即就医。